



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · EDIÇÃO APROFUNDADA

Saúde Mental e Populações Específicas

Saúde mental e RAPS · Pessoa com deficiência
Situação de risco e violência · Assistência domiciliar

PESO MÉDIO · ALTA INCIDÊNCIA

Profa. Fátima Barbosa

Legislação e protocolos conferidos · Ministério da Saúde

O eixo dos direitos

Aqui a prova cobra menos número e mais princípio: o que a lei garante, quem tem direito a quê, e qual conduta respeita a autonomia da pessoa.

Este eixo reúne quatro temas que compartilham uma lógica: são populações que historicamente tiveram direitos negados. Saber a legislação é saber a conduta — e é exatamente isso que a banca testa.

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **Saúde mental** — reforma psiquiátrica, Lei 10.216, RAPS e CAPS.
- ◆ **Pessoa com deficiência** — LBI e acessibilidade.
- ◆ **Situação de risco e violência** — notificação e fluxos.
- ◆ **Assistência domiciliar** — Melhor em Casa e modalidades.

Sumário

1 Saúde mental

Reforma psiquiátrica e Lei 10.216

A RAPS e seus pontos

Os CAPS

Cuidados de enfermagem

2 Pessoa com deficiência

A LBI

Acessibilidade e cuidado

3 Situação de risco e violência

Tipos de violência

Notificação compulsória

Violência sexual

4 Assistência domiciliar

Melhor em Casa

Modalidades AD1, AD2 e AD3

5 Síntese e bizzus finais

Revisão rápida

1

Saúde mental

A reforma psiquiátrica mudou o modelo: de isolar para cuidar em liberdade.

1 • A Lei 10.216/2001

Conhecida como **Lei da Reforma Psiquiátrica** ou **Lei Paulo Delgado**, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial — do **asilar** para o **comunitário**.

Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001

◆ Os três tipos de internação

TIPO	DEFINIÇÃO
Voluntária	Com o consentimento do usuário . Ele assina declaração no momento da admissão.
Involuntária	Sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro . Deve ser comunicada ao Ministério Público em até 72 horas .
Compulsória	Determinada pela Justiça (ordem judicial).

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a internação **involuntária** precisa ser comunicada ao Ministério Público em 72 horas: é uma **salvaguarda contra o abuso**. Historicamente, internar “a pedido da família” foi instrumento de exclusão social — bastava um parente incômodo. Ao exigir que o MP saiba de toda internação sem consentimento, a lei coloca um fiscal externo entre a vontade de terceiros e a liberdade da pessoa. O mesmo vale para a **alta**: também é comunicada.

BIZU ESTRATÉGICO

Guarde pela origem do pedido: **Voluntária** = vontade do usuário. **Involuntária** = pedido de terceiro (MP em 72h). **Compulsória** = Court / juiz. O número **72 horas** é o mais cobrado do tema.

PEGADINHA CLÁSSICA

A lei estabelece que a internação só é indicada quando os recursos **extra-hospitalares se mostrarem insuficientes** — é o **último recurso**, não o primeiro. E é **vedada** a internação em instituições com características asilares. Alternativa que trata a internação como conduta inicial padrão está errada.

◆ Direitos da pessoa com transtorno mental

O QUE A LEI GARANTE

- ◆ Acesso ao **melhor tratamento** do sistema de saúde, conforme suas necessidades.
- ◆ Ser tratada com **humanidade e respeito**, no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde.
- ◆ Proteção contra **qualquer forma de abuso e exploração**.
- ◆ Ser tratada, preferencialmente, em **serviços comunitários** de saúde mental.
- ◆ Ter **livre acesso aos meios de comunicação** e receber o maior número de informações sobre sua doença e tratamento.
- ◆ O tratamento visará, como **finalidade permanente**, a **reinserção social**.

1 • A RAPS

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) operacionaliza o modelo comunitário. Instituída pela Portaria 3.088/2011 (hoje consolidada), organiza-se em componentes que vão da atenção básica à reabilitação.

Portaria GM/MS nº 3.088/2011 · Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 2017

COMPONENTE	PONTOS DE ATENÇÃO
Atenção básica	UBS, equipes de Saúde da Família, NASF, equipes de Consultório na Rua, Centros de Convivência.
Atenção psicossocial especializada	CAPS em suas modalidades.
Atenção de urgência e emergência	SAMU, UPA, portas hospitalares de urgência.
Atenção residencial de caráter transitório	Unidades de Acolhimento (adulto e infantojuvenil) e serviços de atenção em regime residencial.
Atenção hospitalar	Leitos de saúde mental em hospital geral — internações de curta duração.
Estratégias de desinstitucionalização	Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) e Programa de Volta para Casa.
Reabilitação psicossocial	Iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários, cooperativas.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica da RAPS em uma frase: **substituir o hospital psiquiátrico por uma rede**. Onde antes havia *um* lugar (o manicômio) que concentrava tudo — moradia, tratamento, contenção —, hoje há vários serviços com funções distintas: o CAPS trata, o SRT dá moradia, o Centro de Convivência dá vida social, o hospital geral atende a crise aguda. A pessoa **circula** em vez de ficar depositada. Por isso os leitos de saúde mental ficam em **hospital geral**, não em hospital psiquiátrico: para que a crise psíquica seja tratada como qualquer outra crise de saúde.

◆ Os CAPS

MODALIDADE	CARACTERÍSTICA
CAPS I	Municípios/regiões com população acima de 15 mil habitantes. Todas as faixas etárias.
CAPS II	População acima de 70 mil . Todas as faixas etárias.
CAPS III	População acima de 150 mil . Funciona 24 horas , com acolhimento noturno (até 5 leitos).
CAPS i	Infantojuvenil . Crianças e adolescentes. População acima de 70 mil.
CAPS AD	Álcool e outras drogas . População acima de 70 mil.
CAPS AD III	Álcool e drogas, 24 horas , com acolhimento noturno. População acima de 150 mil.

BIZU ESTRATÉGICO

O que diferencia é **porte populacional** e **público**. Guarde os números: **15 mil (I) → 70 mil (II, i, AD) → 150 mil (III e AD III)**. E o III é o único que **funciona 24 horas com acolhimento noturno** — mas atenção: acolhimento noturno **não é internação**; é permanência de curta duração, ainda no serviço aberto.

PEGADINHA CLÁSSICA

O CAPS é um serviço **aberto, comunitário e substitutivo** ao modelo asilar — não é ambulatório nem hospital-dia clássico. O instrumento central do cuidado é o **Projeto Terapêutico Singular (PTS)**, construído *com* o usuário, e a porta de entrada é o **acolhimento** — inclusive por demanda espontânea, sem necessidade de encaminhamento.

Nota de atualização

Em janeiro de 2026 o Ministério da Saúde criou grupo de trabalho (Portaria nº 10) para **revisar as diretrizes e o custeio da RAPS**, com representantes do CONASS e do CONASEMS. Ou seja: as normas de organização e financiamento da rede estão em **processo de revisão**. Os fundamentos da Lei 10.216 permanecem — mas acompanhe eventuais mudanças nas portarias antes da prova.

1 · Cuidados de enfermagem em saúde mental

O QUE A PROVA COBRA NA CONDUTA

- ◆ **Relacionamento terapêutico:** escuta ativa, empatia, postura não julgadora.
- ◆ **Comunicação terapêutica:** perguntas abertas, validação, silêncio como recurso.
- ◆ Diante de **delírio ou alucinação:** **não confrontar** nem reforçar. Não discutir a veracidade — acolher o sentimento e trazer para a realidade compartilhada.
- ◆ **Contenção:** é o **último recurso**, pelo menor tempo possível, com prescrição e monitorização. Nunca punição.
- ◆ **Risco de suicídio:** perguntar diretamente **não induz** ao ato — ao contrário, abre espaço para o cuidado.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que **não se confronta o delírio**: para a pessoa, ele é experiência *real* — argumentar “isso não existe” não convence e ainda rompe o vínculo, porque ela sente que você não acredita nela. A técnica correta é não afirmar nem negar o conteúdo: acolhe-se o **sentimento** (“percebo que isso te assusta”) e ancora-se na realidade sem confronto. Você trata a angústia, não debate o conteúdo.

PEGADINHA CLÁSSICA

Mito que a banca explora: perguntar sobre suicídio “planta a ideia”. **Falso** — a evidência mostra o oposto: perguntar de forma direta e acolhedora **reduz** a angústia e permite intervir. Alternativa que orienta “evitar o assunto para não sugestionar” está **errada**.

2

Pessoa com deficiência

A deficiência não está na pessoa. Está na barreira que a sociedade impõe.

2 · A Lei Brasileira de Inclusão

A LBI — Lei 13.146/2015, também chamada **Estatuto da Pessoa com Deficiência**, é o marco legal do tema.

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 — Lei Brasileira de Inclusão

Sua definição de deficiência é o ponto que a prova mais explora:

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O modelo mudou — e a lei incorporou a mudança. No modelo antigo (*médico*), a deficiência era um **atributo do corpo**: a pessoa “é deficiente” porque falta algo nela. No modelo atual (**biopsicossocial**), adotado pela LBI, a deficiência resulta da **interação** entre o impedimento de longo prazo e as **barreiras** do ambiente.

A consequência prática é enorme: um cadeirante numa cidade com rampas e transporte acessível participa plenamente; o *mesmo* cadeirante numa cidade de escadas está impedido. O impedimento é o mesmo — a deficiência, não. Por isso a intervenção recai sobre a **barreira**, não sobre o corpo.

TIPO DE BARREIRA	DEFINIÇÃO
Barreiras urbanísticas	Vias, espaços públicos, mobiliário urbano.
Barreiras arquitetônicas	Edifícios públicos e privados.
Barreiras nos transportes	Sistemas e meios de transporte.
Barreiras nas comunicações	Impedem expressão e recebimento de mensagens (ex.: ausência de Libras, material sem acessibilidade).
Barreiras atitudinais	Atitudes e comportamentos que prejudicam a participação — o preconceito. É a mais cobrada.
Barreiras tecnológicas	Dificultam o acesso à tecnologia.

BIZU ESTRATÉGICO

A **barreira atitudinal** é a favorita da banca: é a do *comportamento* — tratar o adulto com deficiência como criança, falar com o acompanhante em vez de falar com a pessoa, presumir incapacidade. E lembre: a LBI garante **atendimento prioritário**, e a deficiência **não afeta a plena capacidade civil** — inclusive para casar, ter filhos e decidir sobre o próprio corpo.

PEGADINHA CLÁSSICA

Conduta que cai: **fale diretamente com a pessoa com deficiência**, não com o acompanhante ou intérprete. Pergunte *antes* de ajudar — empurrar a cadeira sem pedir licença é desrespeito à autonomia. E a pessoa com deficiência tem direito a **acompanhante ou atendente pessoal** nos serviços de saúde.

3

Situação de risco e violência

Notificar não é denunciar. É proteger — e é obrigação legal.

3 · Tipos de violência

TIPO	DEFINIÇÃO
Física	Uso da força que cause dano, sofrimento físico ou lesão.
Psicológica	Dano emocional: humilhação, ameaça, constrangimento, isolamento, vigilância constante.
Sexual	Constranger a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, por qualquer meio.
Patrimonial	Reter, subtrair ou destruir bens, documentos, recursos econômicos.
Moral	Calúnia, difamação ou injúria.
Negligência/abandono	Omissão do cuidado devido — frequente contra crianças e idosos.
Autoprovocada	Autoagressão, tentativa de suicídio.

BIZU ESTRATÉGICO

A Lei Maria da Penha (11.340/2006) tipifica cinco formas de violência doméstica e familiar contra a mulher: **física, psicológica, sexual, patrimonial e moral**. Decore as cinco — a banca inclui uma sexta inventada ou tira a patrimonial (que é a mais esquecida).

3 · Notificação compulsória

A notificação de violência é **obrigatória** para todos os serviços de saúde, **públicos e privados**. Ela é feita na **ficha de notificação de violência interpessoal/autoprovocada do SINAN**.

Lei 10.778/2003 (alterada pela Lei 13.931/2019) · ECA · Estatuto da Pessoa Idosa · Portaria GM/MS 1.271/2014

ITEM	REGRA
Quem notifica	Qualquer profissional de saúde, em serviço público ou privado. Caso suspeito ou confirmado — não é preciso ter certeza.
Instrumento	Ficha de notificação de violência interpessoal/autoprovocada — SINAN .
Prazo geral	Semanal, conforme a lista de notificação compulsória.
Notificação IMEDIATA (≤ 24h)	Violência sexual e tentativa de suicídio.
Violência contra a mulher	Além da notificação, a Lei 13.931/2019 exige comunicação à autoridade policial em até 24 horas .
Criança e adolescente	Comunicação obrigatória ao Conselho Tutelar (ECA, Lei 8.069/1990).
Pessoa idosa	Comunicação à autoridade policial, Ministério Público e Conselhos do Idoso (Lei 12.461/2011).

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A distinção que resolve quase toda questão do tema: **notificar ≠ denunciar**. A **notificação** é um ato de **vigilância em saúde** — alimenta o SINAN, dimensiona o problema e aciona a rede de proteção. Tem caráter **sigiloso**. A **denúncia** é ato policial/judicial. O profissional de saúde **notifica sempre**; a decisão de denunciar, em regra, é da vítima adulta.

Por isso a notificação **não depende da vontade da vítima** nem de boletim de ocorrência: é obrigação legal do serviço, não escolha da pessoa.

PEGADINHA CLÁSSICA

Três erros clássicos: (1) achar que só se notifica caso **confirmado** — notifica-se a **suspeita**; (2) achar que serviço **privado** não notifica — notifica sim; (3) condicionar a notificação à **autorização da vítima** ou ao boletim de ocorrência — não se condiciona. E notificar **não fere o sigilo profissional**: é dever legal previsto em lei.

3 · Atendimento à violência sexual

AS CONDUTAS NAS PRIMEIRAS HORAS

- ◆ **Acolhimento humanizado**, em ambiente reservado, sem julgamento e sem revitimização.
- ◆ **Contracepção de emergência**: levonorgestrel, o mais precoce possível (até 72h, podendo estender).
- ◆ **PEP para HIV**: até **72 horas**, por **28 dias**.
- ◆ **Profilaxia de IST**: incluindo **penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única** para sífilis — independentemente do teste rápido.
- ◆ **Profilaxia de hepatite B**: vacina + imunoglobulina (IGHAB) em suscetíveis.
- ◆ **Notificação imediata** ($\leq 24h$) no SINAN. Coleta de vestígios conforme norma técnica.
- ◆ Informar sobre o direito ao **aborto legal**, se houver gravidez.

PEGADINHA CLÁSSICA

Ponto de ouro: **não se exige boletim de ocorrência, laudo do IML nem autorização judicial** para o atendimento à vítima de violência sexual no SUS — nem para as profilaxias, nem para o aborto legal. Exigir esses documentos é **barreira ilegal** e revitimização. A banca adora essa alternativa.

BIZU ESTRATÉGICO

O relógio das **72 horas** vale para as duas profilaxias mais cobradas: **PEP** (28 dias de duração) e **contracepção de emergência** (quanto mais precoce, mais eficaz). Se o enunciado disser que a vítima chegou em 2 horas, a resposta envolve as duas.

4

Assistência domiciliar

Levar o cuidado até a casa — e desospitalizar com segurança.

4 · O Melhor em Casa

A **Atenção Domiciliar (AD)** no SUS é organizada pelo programa **Melhor em Casa**. A equipe é a **EMAD** (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar), com apoio da **EMAP** (Equipe Multiprofissional de Apoio).

MODALIDADE	CARACTERÍSTICA
AD 1	Menor complexidade. Responsabilidade da atenção básica (equipe de Saúde da Família). Pessoas com problemas estáveis, que precisam de cuidado de menor frequência.
AD 2	Maior complexidade. Responsabilidade da EMAD . Necessita de cuidado mais frequente, uso de equipamentos, procedimentos como curativos complexos, sondas.
AD 3	Como a AD 2, porém com uso de equipamentos de maior complexidade (ex.: ventilação mecânica, paracentese de repetição, diálise peritoneal). Também da EMAD.

BIZU ESTRATÉGICO

A régua é a **complexidade** e a **frequência** do cuidado: **AD1 = atenção básica** (estável); **AD2 e AD3 = EMAD** (mais complexo), sendo a **AD3** a que envolve **equipamento de maior complexidade**. Mnemônico: quanto maior o número, maior a tecnologia dentro de casa.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A atenção domiciliar não é só “desospitalizar para economizar”. Há razão clínica: em casa, o paciente tem **menos risco de infecção relacionada à assistência**, mantém vínculo familiar e autonomia, e a família é incorporada como **cuidadora**. Por isso a AD exige duas condições que a prova cobra: **consentimento** da família e **cuidador identificado** — sem cuidador, não há AD.

PEGADINHA CLÁSSICA

Requisitos da elegibilidade: paciente com **estabilidade clínica**, **cuidador identificado** e **concordância da família**. Paciente instável, sem cuidador ou com domicílio sem condições mínimas **não** é elegível. A banca oferece “paciente crítico instável” para AD — errado.

5

Síntese

Os princípios e prazos que decidem a questão.

5 · Revisão rápida do eixo

SAÚDE MENTAL

- ◆ Lei **10.216/2001**: modelo comunitário; internação é **último recurso**; vedada instituição asilar.
- ◆ Internações: **voluntária** (consentimento) · **involuntária** (terceiro → **MP em 72h**) · **compulsória** (juiz).
- ◆ CAPS: **I (15 mil)** · **II, i, AD (70 mil)** · **III e AD III (150 mil, 24h)**. Serviço **aberto e substitutivo**.
- ◆ Leitos de saúde mental em **hospital geral**. Instrumento do cuidado: **PTS**.
- ◆ Delírio: **não confrontar**. Suicídio: **perguntar não induz**. Contenção: último recurso.

DEFICIÊNCIA, VIOLÊNCIA E DOMICILIAR

- ◆ LBI (**13.146/2015**): modelo **biopsicossocial** — deficiência = impedimento + **barreira**.
- ◆ Barreira **atitudinal** é a do comportamento. Fale **com a pessoa**, não com o acompanhante.
- ◆ Maria da Penha: **5 tipos** — física, psicológica, sexual, patrimonial, moral.
- ◆ Notificação: **suspeita já basta**; público **e privado**; **não depende** da vítima nem de BO. **Notificar ≠ denunciar**.
- ◆ **Imediata (24h)**: violência sexual e tentativa de suicídio. Mulher: polícia em **24h** (Lei 13.931/2019).
- ◆ Violência sexual: PEP **72h/28 dias** + contracepção de emergência + penicilina benzatina. **Sem exigir BO**.
- ◆ AD: **AD1 = atenção básica**; **AD2 e AD3 = EMAD**. Exige **cuidador** e estabilidade.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas campeãs do eixo: (1) comunicar internação involuntária ao juiz em vez do **MP**; (2) tratar internação como primeira conduta; (3) confrontar o delírio; (4) evitar falar de suicídio “para não sugerir”; (5) exigir BO na violência sexual; (6) achar que serviço privado não notifica; (7) indicar AD para paciente instável ou sem cuidador. Domine essas sete e o eixo é seu.

“Neste eixo, a resposta certa é quase sempre a que respeita a autonomia e mantém a pessoa em liberdade.”

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · SAÚDE MENTAL E POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

Legislação e protocolos conferidos nas fontes oficiais: Lei 10.216/2001, Lei 13.146/2015 (LBI), Lei 11.340/2006, Lei 10.778/2003 (alterada pela Lei 13.931/2019), normas da RAPS e do programa Melhor em Casa. As portarias da RAPS estão em processo de revisão — confirme a versão vigente antes da prova.